



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Відділення променевої діагностики Радіологічний звіт

Пацієнт Жерліцина Анастасія Станіславівна
ID 110889

Дата народження 25.04.1976

Дата дослідження 19.05.2025

Дослідження ретроспективний аналіз наданих обстежень

Клінічні дані/завдання дослідження:

Код за МКХ-10:C16.9 - Злоякісне новоутворення шлунка, не уточнене. Діагноз: Лейоміосаркома тіла матки, T2NxM1, вторинне ураження печінки, брюшини. Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін + Доцетаксел + Авастин з прогресією хвороби в печінці (за даними КТ, МРТ від 10/2022). Виявлена мутація C-KIT, MET (ONCOMINE). Стан після лікування Пазопанібом (05-12/01/2023) з розвитком синдрому задньої зворотної енцефалопатії та позитивною динамікою за даними КТ. 01/2023 - повторна біопсія печінки. ПГД - метастаз лейоміосаркоми матки. Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектидін з негативною рентгенологічною динамікою (ПЕТ/КТ від 11/04/2023). Підозра на наявність синхронної неоплазії шлунку (GIST?). Стан після EUS-FNA біопсії шлунку, core-біопсії печінки, гістологічно - гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD). 08/2023 - стан після 4-х місяців лікування Іматинібом з вираженою позитивною радіологічною (ПЕТ/КТ) відповіддю. 03/2025 - стан після 2х років лікування Іматинібом з позитивною клінічною картиною.

Дані попередніх досліджень для порівняння: ПЕТ/КТ з ФДГ 14/03/2024, 17/08/2023, архіви до 08/2022

Методика дослідження: для ретроспективного аналізу надані дані ПЕТ/КТ з ФДГ 13/05/2025

Знахідки:

Знахідки

Голова та шия

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; без суттєвої динаміки, немає нової суспектної лімфаденопатії, тромбів чи аневризм великих судин.

Грудна клітка

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; відомі дрібні легеневі вузлики стабільні; нових активних/підозрілих легневих вузлів чи консолідацій не знайдено.

Елементи тимусу зменшилися (товщиною до 17 мм), більше не демонструють помірного підвищення активності.

Немає надлишкової плевральної та перикардіальної рідини, нової суспектної лімфаденопатії, тромбів великих судин.

Місце провадження діяльності:
08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27

Юридична адреса:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77

ТОВ "Медікс-рей Інтернешнл Груп"

ЄДРПОУ 32109302, ІПН 321093026557

IBAN UA50 380838 00000 26006700394119 в АТ «Правекс банк» МФО 380838

IBAN UA19 305299 00000 26000026804357 в АТКБ «Приватбанк» МФО 305299

IBAN UA88 380805 00000 26004702687726 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805

тел.: 0 800 500 110
(Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України)

тел.: +38 (044) 277 8 277

факс: +38 (044) 520 94 01

www.lisod.ua



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Живіт і таз

Відомі переважно кістозні залишки мас в печінці без істотної динаміки розмірів, домінантна в правій частці трохи зменшилася з 15 до 13,5 см. Як і при попередній візуалізації не демонструють істотного підвищення активності, зокрема і периферичних компонентів, проте у вузлі в 8 сегменті новий «пристінковий» кулястий щільний вузлик розміром 11 мм, без помітного відповідного істотного осередкового підвищення активності.

Нових окремих гіперметаболических осередків у печінці не знайдено.

Відома маса з стінки шлунку також і зараз без активних солідних компонентів, не демонструє підвищеного накопичення ФДГ, також і зменшилася з 40 до 35 мм, в ній розвинулися дрібні звапнення.

Знову невелике коливання розмірів неактивних маси у матці, наприклад, відносно краніальніша/найбільша з 78 до 84 мм, як і при попередній візуалізації, демонструють низьку активність, структура їх без динаміки.

В іншому, без істотної динаміки, нових активних/підозрілих осередкових паренхіматозних уражень, нової лімфаденопатії не знайдено.

Кістки та м'які тканини

Як і при попередньому дослідженні, гіперметаболических кісткових уражень не знайдено, агресивних за структурними/КТ ознаками кісткових уражень не знайдено, без динаміки.

Радіологічний висновок:

Порівняно із 03/2025, подальше невелике зменшення неактивних залишків мас печінки та шлунку, поява нового пристінкового вузлика у домінантній масі печінки, проте метаболічно неактивного (можливо і внаслідок крововиливу), доцільний подальший контроль.

Нових окремих активних/підозрілих уражень не знайдено.

Лікар:

Новіков М.Є.

19.05.2025 10:21